पारिवारिक सामान्य दुर्घटनाएँ एवं उनका निदान

Common Family Accidents and First Aid

दुर्घटना और प्राथमिक सहायता

घरेलू दुर्घटना (**Home Accident**) घर या उसके आसपास होने वाली ऐसी घटना है जिससे चोट, जलना, विषाक्तता या अन्य नुकसान हो सकता है। रसोई, सीढ़ी, स्नानघर, विद्युत उपकरण, दवाएँ और छोटे खिलौने इसके सामान्य जोखिम-क्षेत्र हैं।

प्राथमिक चिकित्सा (**First Aid**) बीमारी या चोट में दी जाने वाली तत्काल प्रारंभिक सहायता है। इसके प्रमुख उद्देश्य जीवन की रक्षा, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और आवश्यक चिकित्सा तक पहुँचने में सहयोग देना हैं।

निदान का व्यावहारिक अर्थ

यहाँ दुर्घटना की पहचान, खतरे का आकलन और प्रारंभिक प्रबंधन समझाया गया है। लक्षणों से स्थिति का संदेह किया जा सकता है; अंतिम चिकित्सकीय निदान और विशेषज्ञ उपचार स्वास्थ्य पेशेवर की जिम्मेदारी हैं।

चरण	प्रमुख दिशा
घटना से पहले	जोखिम पहचानना और बचाव
घटना के समय	सुरक्षा, जीवनरक्षक सहायता और मदद
घटना के बाद	चिकित्सा, निगरानी और कारण में सुधार

जानकारी और कौशल

CPR, गले में वस्तु फँसने की सहायता और अन्य व्यावहारिक कौशल का प्रशिक्षक के साथ अभ्यास उपयोगी है। आपात स्थिति में सहायता बुलाएँ तथा कॉल संचालक के निर्देश का पालन करें।

> सही प्राथमिक सहायता स्थिति पहचानती है, नुकसान कम करती है और उचित चिकित्सा से जोड़ती है।

घटनास्थल की सुरक्षा और सहायता बुलाना

Scene Safety and Calling for Help

स्वयं सुरक्षित रहें

आग, धुआँ, खुला बिजली तार, रसायन और गहरा पानी सहायता देने वाले को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। सुरक्षित हुए बिना खतरे वाले क्षेत्र में प्रवेश न करें। एक और घायल व्यक्ति बनना बचाव को कठिन करता है।

प्रारंभिक प्राथमिकता

- घटनास्थल के खतरे और व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखें।
- जीवनघाती रक्तस्राव हो तो तुरंत नियंत्रण का प्रयास करें।
- प्रतिक्रिया न मिलने पर सामान्य श्वसन का आकलन और आपात सहायता जरूरी है।
- किसी अन्य व्यक्ति को फोन करने और आवश्यक सामग्री लाने का स्पष्ट काम दें।

भारत में आपात सहायता

112 भारत की एकीकृत आपात प्रतिक्रिया संख्या है। फोन पर स्थान, निकट पहचान-स्थल, घटना, व्यक्तियों की संख्या, प्रतिक्रिया और श्वसन की स्थिति स्पष्ट बताएँ। अकेले हों तो फोन का स्पीकर उपयोग करके निर्देश लेते हुए सहायता जारी रख सकते हैं।

आश्वासन और सम्मान

जाग्रत व्यक्ति को शांत भाषा में बताएँ कि क्या कर रहे हैं। अनावश्यक भीड़ हटाएँ और निजी जानकारी का सम्मान करें। जीवनरक्षक सहायता तथा आपात संपर्क में देरी न करें।

> बिजली, आग या गैस का खतरा बना हो तो पहले सुरक्षित दूरी और विशेषज्ञ बचाव की व्यवस्था करें।

प्राथमिक आकलन की व्यवस्थित प्रक्रिया

Structured Primary Assessment

प्रतिक्रिया और जीवन के खतरे

व्यक्ति को संबोधित करें और कंधे पर हल्का स्पर्श करके प्रतिक्रिया देखें। गंभीर चोट में जोर से हिलाना उचित नहीं है। सुरक्षा, प्रतिक्रिया और अत्यधिक रक्तस्राव पर प्रारंभिक ध्यान दें।

ABCDE का अर्थ

संकेत	अर्थ	आकलन की दिशा
A	**Airway**: वायुमार्ग	हवा का रास्ता खुला है या बाधा है?
B	**Breathing**: श्वसन	सामान्य साँस है या नहीं?
C	**Circulation**: परिसंचरण	गंभीर रक्तस्राव और शॉक के संकेत
D	**Disability**: चेतना संबंधी स्थिति	प्रतिक्रिया, भ्रम या दौरा
E	**Exposure**: चोट का निरीक्षण	जरूरी निरीक्षण और ठंड से सुरक्षा

सहायता की प्राथमिकता

ABCDE प्रशिक्षित आकलन का ढाँचा है। सामान्य व्यक्ति नाड़ी खोजने या पूरा निरीक्षण करने में **CPR** देर से शुरू न करे। प्रतिक्रिया नहीं और साँस सामान्य नहीं हो तो हृदयगति रुकने की संभावना समझें।

श्वसन का सही अर्थ

कभी-कभी आने वाली हाँफने जैसी साँस (**Agonal Gasping**) सामान्य श्वसन नहीं है। श्वसन जाँच में लगभग 10 सेकंड से अधिक समय न लगाएँ।

> जीवनघाती समस्या की पहचान होते ही सहायता दें; पूरी सूची समाप्त होने का इंतजार न करें।

वयस्क में हृदयगति रुकना और CPR

Adult Cardiac Arrest and CPR

कब CPR की आवश्यकता है?

व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं दे रहा और साँस नहीं है या सामान्य नहीं है तो हृदयगति रुकने (**Cardiac Arrest**) का संदेह करें। 112 पर सहायता बुलाएँ, **AED** मँगवाएँ और तुरंत **CPR** शुरू करें।

छाती दबाने की मुख्य बातें

पक्ष	वयस्क के लिए दिशा
स्थान	छाती के बीच उरोस्थि के निचले आधे भाग पर हाथ की एड़ी
हाथ और शरीर	दूसरा हाथ ऊपर, उँगलियाँ जुड़ीं; बाँहें सीधी
गति	100 से 120 दबाव प्रति मिनट
गहराई	लगभग 5 से 6 cm
दबाव के बाद	छाती को पूरा वापस उठने दें; लगातार झुककर दबाव न रखें

साँस देना और सहायता जारी रखना

प्रशिक्षित और सक्षम हों तो 30 दबाव के बाद 2 बचाव साँसें दें; छाती उठने जितनी हवा पर्याप्त है। साँस देना नहीं जानते या नहीं दे सकते तो लगातार छाती दबाएँ और कॉल संचालक का निर्देश लें।

अनावश्यक देरी से बचें

CPR जहाँ व्यक्ति है वहीं तुरंत शुरू करें; केवल बिस्तर से फर्श पर लाने के लिए देरी न करें। मदद संभाल ले, व्यक्ति सामान्य साँस लेने लगे या जारी रखना संभव न रहे तब स्थिति के अनुसार रुकें।

> सामान्य साँस लेने वाले व्यक्ति पर **CPR** नहीं किया जाता।

AED और आयु के अनुसार जीवनरक्षक सहायता

AED and Age-Specific Life Support

AED का कार्य

स्वचालित बाह्य डिफिब्रिलेटर (**Automated External Defibrillator**; **AED**) हृदय की लय का विश्लेषण करके जरूरत होने पर विद्युत झटका देने का निर्देश देता है। यह **CPR** और आपात चिकित्सा के साथ उपयोग होता है।

उपयोग का क्रम

1	**उपकरण चालू करें**	आवाज और चित्र के निर्देश सुनें तथा देखें।
2	**पैड लगाएँ**	निर्देश के अनुसार नंगी और सूखी छाती पर।
3	**दूरी रखें**	विश्लेषण और झटका देते समय कोई व्यक्ति रोगी को न छुए।
4	**CPR जारी करें**	झटके या विश्लेषण के बाद उपकरण के निर्देश के अनुसार।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

विश्लेषण और झटका देते समय कोई व्यक्ति रोगी को न छुए। छाती गीली हो तो जल्दी सुखाएँ। पैड का स्थान उपकरण पर दिए चित्र के अनुसार रखें। झटका न देने का निर्देश आए तो भी उपकरण के अनुसार **CPR** जारी रखें।

बच्चे और शिशु

बच्चे तथा शिशु में साँसों का महत्त्व और **CPR** की तकनीक वयस्क से अलग हो सकती है। वयस्क की 5 से 6 cm गहराई शिशु पर लागू न करें। बाल जीवनरक्षक प्रशिक्षण और कॉल संचालक के निर्देश का उपयोग करें।

बाल **CPR** के प्रचलित प्रशिक्षण में प्रारंभिक 5 बचाव साँसें शामिल होती हैं। छोटे बच्चे के लिए बाल पैड या बाल मोड उपलब्ध हो तो उपकरण के निर्देश के अनुसार उपयोग करें।

> **AED** के निर्देश सुनें; सहायता और **CPR** को अनावश्यक रूप से न रोकें।

बेहोशी, मूर्छा और रिकवरी पोज़िशन

Fainting and the Recovery Position

मूर्छा और लंबे समय की बेहोशी

मूर्छा (**Fainting**) में व्यक्ति थोड़े समय के लिए चेतना खो सकता है। हर बेहोशी को साधारण मूर्छा न मानें; चोट, हृदय की समस्या, कम रक्त शर्करा और अन्य कारण संभव हैं।

स्थिति	प्रारंभिक दिशा
चक्कर लेकिन जाग्रत	सुरक्षित लेटाएँ; चोट न हो तो पैर थोड़ा ऊपर रख सकते हैं
प्रतिक्रिया नहीं, सामान्य साँस	सहायता बुलाएँ; बिना चोट की स्थिति में करवट वाली रिकवरी पोज़िशन
प्रतिक्रिया नहीं, साँस सामान्य नहीं	**CPR** और **AED** की व्यवस्था

करवट का उद्देश्य

रिकवरी पोज़िशन (**Recovery Position**) सामान्य साँस वाले अचेत व्यक्ति का वायुमार्ग खुला रखने और उल्टी बाहर निकलने में सहायता करती है। श्वसन लगातार देखते रहें; यह **CPR** का विकल्प नहीं है।

चोट में सावधानी

सिर, गर्दन या रीढ़ की चोट का संदेह हो तो नियमित रूप से करवट न दिलाएँ। वायुमार्ग और श्वसन की जरूरत सर्वोच्च है; उल्टी या तत्काल खतरे में आवश्यक न्यूनतम हिलाना प्रशिक्षित सहायता अथवा आपात निर्देश के अनुसार करें।

तत्काल चिकित्सा के संकेत

जल्दी चेतना न लौटना, सीने में दर्द, साँस की समस्या, दौरा या गंभीर चोट आपात संकेत हैं।

> बेहोश व्यक्ति को पानी, भोजन, गोली या चीनी मुँह से न दें।

गंभीर बाह्य रक्तस्राव

Severe External Bleeding

पहचान

तेजी से बहता रक्त, लगातार भीगता कपड़ा, रक्त जमा होना और व्यक्ति में कमजोरी या चेतना कम होना गंभीर रक्तस्राव के संकेत हो सकते हैं। रक्त के रंग से अधिक उसके बहाव और व्यक्ति की स्थिति पर ध्यान दें।

तत्काल सहायता

- उपलब्ध हों तो दस्ताने पहनें; इससे सहायता में अनावश्यक देरी न हो।
- साफ कपड़ा या ड्रेसिंग रखकर घाव पर मजबूत, लगातार सीधा दबाव दें।
- किसी को 112 पर फोन करने को कहें और दबाव जारी रखें।
- रक्तस्राव नियंत्रित होने पर उपयुक्त ड्रेसिंग सुरक्षित रखें और स्थिति देखते रहें।

अलग परिस्थितियाँ

घाव में वस्तु या बाहर निकली हड्डी पर सीधा दबाव न दें; आसपास दबाव और आवश्यक चिकित्सा की व्यवस्था करें। छाती के खुले घाव को साधारण घाव की तरह हवा बंद करके न बाँधें।

टूर्निकेट का सीमित उपयोग

हाथ या पैर का जीवनघाती रक्तस्राव सीधे दबाव से नियंत्रित न हो तो प्रशिक्षित व्यक्ति उपयुक्त टूर्निकेट (**Tourniquet**) उपयोग कर सकता है। लगाए समय को दर्ज करें; इसे स्वयं बार-बार ढीला न करें। सामान्य कट में रस्सी कसना उचित नहीं है।

> अत्यधिक रक्तस्राव में तुरंत दबाव और आपात सहायता जीवनरक्षक प्राथमिकता हैं।

छोटे कट, खरोंच और घाव

Minor Cuts, Grazes and Wounds

घावों की सामान्य पहचान

प्रकार	प्रमुख अर्थ
खरोंच (**Abrasion**)	त्वचा की सतह रगड़ने से चोट
कट (**Cut**)	धारदार वस्तु से त्वचा कटना
फटा घाव (**Laceration**)	ऊतक का अनियमित रूप से फटना
छेद वाला घाव (**Puncture Wound**)	नुकीली वस्तु से छोटा प्रवेश लेकिन गहरी चोट संभव

छोटे घाव की सहायता

हाथ साफ करें। रक्तस्राव हो तो सीधे दबाव से रोकें। छोटे घाव को साफ बहते पानी से धोएँ तथा आसपास की त्वचा साफ करें। उपयुक्त कीटाणुरहित ड्रेसिंग (**Sterile Dressing**) या साफ पट्टी से ढकें।

कब चिकित्सा चाहिए?

गहरा या खुला घाव, लगातार रक्तस्राव, सुन्नपन, वस्तु फँसना, जानवर या मनुष्य का काटना और बढ़ता दर्द चिकित्सा की जरूरत बता सकते हैं। मिट्टी या गहरे छेद वाले घाव में टिटनेस सुरक्षा की समीक्षा भी आवश्यक है।

संक्रमण के संकेत

दर्द, गर्माहट, सूजन, फैलती लालिमा, पस या बुखार होने पर सेवा लें। घाव में मिट्टी, राख, हल्दी या अप्रमाणित पदार्थ न भरें।

> छोटा दिखने वाला छेद भी गहरा हो सकता है; केवल बाहरी आकार से चोट की गंभीरता तय न करें।

फँसी वस्तु और अलग हुए अंग का संरक्षण

Embedded Objects and Amputated Parts

घाव में फँसी वस्तु

काँच, धातु या अन्य वस्तु गहराई में फँसी हो तो उसे खींचकर न निकालें। आसपास सहारा देकर हिलना कम करें। रक्तस्राव में वस्तु के आसपास दबाव दें और चिकित्सा तक पहुँचाएँ।

उँगली या अंग अलग होने पर

व्यक्ति का रक्तस्राव तथा जीवनरक्षक सहायता पहले करें। अलग हुआ भाग सुरक्षित मिल सके तो उसे व्यक्ति के साथ अस्पताल भेजें। उसे जोड़ने या घाव में वापस रखने का प्रयास न करें।

संरक्षण का क्रम

चरण	कार्रवाई
लपेटना	साफ ड्रेसिंग को पानी या सलाइन से हल्का नम कर भाग लपेटें
बंद पात्र	साफ जलरोधी थैली या डिब्बे में रखें
ठंडा रखना	बंद पात्र को बाहर से बर्फ या बर्फ-पानी वाले दूसरे पात्र से ठंडा रखें
पहचान	नाम तथा समय दर्ज करके उसी अस्पताल तक भेजें

सावधानी

अलग भाग को सीधे बर्फ पर न रखें, न जमाएँ और न पानी में खुला डुबोएँ। उससे संबंधित निर्णय विशेषज्ञ करते हैं; संरक्षण और समय पर पहुँच उपयोगी हैं।

> घायल व्यक्ति की सहायता पहले; अलग हुए भाग का सुरक्षित संरक्षण उसके बाद।

शॉक और आंतरिक रक्तस्राव

Shock and Internal Bleeding

शॉक की संकल्पना

परिसंचरण संबंधी शॉक (**Circulatory Shock**) में महत्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाते। गंभीर रक्तस्राव, बड़ी चोट या अन्य कारण से यह जीवनघाती स्थिति बन सकती है।

संभावित संकेत

- पीली या बदरंग, ठंडी और नम त्वचा।
- कमजोरी, चक्कर, बेचैनी या भ्रम।
- तेज श्वसन और चेतना में कमी।
- बड़ी चोट के बाद पेट दर्द, सूजन या तेजी से बिगड़ती स्थिति।

प्राथमिक सहायता

आपात मदद बुलाएँ। दिखने वाले गंभीर रक्तस्राव को नियंत्रित करें। व्यक्ति को सुरक्षित लेटाएँ, अनावश्यक चलना रोकें और कंबल से ठंड से बचाएँ। साँस लेने में कठिनाई हो तो उपयुक्त आरामदायक स्थिति तथा आपात निर्देश का पालन करें।

आंतरिक रक्तस्राव

बाहर रक्त न दिखने पर भी बड़ी चोट के बाद अंदर रक्तस्राव हो सकता है। पेट दबाकर जाँच करना या “रक्त नहीं दिख रहा” कहकर अस्पताल जाने में देरी करना उचित नहीं है।

आवश्यक सीमा

भोजन या पेय न दें। संदिग्ध पैर, श्रोणि या रीढ़ की चोट में पैर उठाने और स्थिति बदलने से बचें।

> शॉक केवल डर का दूसरा नाम नहीं है; परिसंचरण संबंधी शॉक आपात चिकित्सा की जरूरत है।

नाक से रक्तस्राव

Nosebleeds

नकसीर की पहचान

नाक से रक्तस्राव (**Nosebleed**; **Epistaxis**) चोट, नाक कुरेदने या अन्य कारणों से हो सकता है। सहायता में सही स्थिति और नाक के सही भाग पर दबाव महत्वपूर्ण हैं।

सहायता का क्रम

1	**बैठाएँ**	व्यक्ति को आगे की ओर थोड़ा झुकाएँ।
2	**दबाव दें**	नथुनों के ठीक ऊपर नरम भाग को 10 से 15 मिनट दबाएँ।
3	**मुँह से साँस**	गले में आया रक्त थूकें; सिर पीछे न करें।
4	**स्थिति देखें**	रक्तस्राव जारी या गंभीर हो तो चिकित्सा लें।

क्या न करें?

सिर पीछे न करें और सीधे पीठ के बल न लेटाएँ। इससे रक्त गले में जा सकता है। नाक की ऊपर की हड्डी दबाने के बजाय नरम निचला भाग दबाएँ। बार-बार छोड़कर देखने से रक्तस्राव दोबारा बढ़ सकता है।

चिकित्सा की जरूरत

10 से 15 मिनट के उचित दबाव के बाद भी रक्तस्राव जारी रहे, बहुत अधिक रक्त बहे, साँस में समस्या हो, चक्कर आए या बड़ी सिर की चोट के बाद शुरू हुआ हो तो तत्काल चिकित्सा लें।

रक्त पतला करने वाली दवा लेने वाले व्यक्ति को विशेष समीक्षा की जरूरत हो सकती है। गंभीर स्थिति में 112 पर सहायता बुलाएँ।

> नकसीर में बैठना, आगे झुकना और नरम भाग पर लगातार दबाव मुख्य प्रारंभिक उपाय हैं।

मोच, खिंचाव और नील पड़ना

Sprains, Strains and Bruises

चोट का अंतर

मोच (**Sprain**) में जोड़ के लिगामेंट और खिंचाव (**Strain**) में मांसपेशी या टेंडन प्रभावित हो सकते हैं। नील (**Bruise**) में त्वचा के नीचे रक्त जमा होने से रंग बदल सकता है।

प्रारंभिक संरक्षण: PRICE

संकेत	अर्थ	उपयोग
P	**Protection**	घायल भाग को आगे की चोट से बचाएँ
R	**Rest**	दर्द बढ़ाने वाला भार और गतिविधि रोकें
I	**Ice**	कपड़े में ठंडा पैक, लगभग 15 से 20 मिनट
C	**Compression**	उपयुक्त हल्का सहारा; बहुत कसकर नहीं
E	**Elevation**	आरामदायक हो और गंभीर चोट का संदेह न हो तो ऊपर रखें

सावधानी

बर्फ सीधे त्वचा पर न रखें। शुरुआती चोट पर जोरदार मालिश या गर्म सिकाई से बचें। आराम का अर्थ बिना समीक्षा लंबे समय तक हर गतिविधि बंद रखना नहीं; आगे की गति दर्द और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार हो।

फ्रैक्चर की संभावना

टेढ़ापन, बहुत दर्द, सुन्नपन, भार न रख पाना या ठंडा और बदरंग अंग हड्डी या गंभीर चोट का संकेत हो सकता है। केवल “मोच” मानकर चलाना उचित नहीं है।

> मोच और फ्रैक्चर के लक्षण मिल सकते हैं; संदेह में चिकित्सा और अनावश्यक गति से बचाव जरूरी है।

हड्डी टूटना और जोड़ खिसकना

Fractures and Dislocations

परिचय

फ्रैक्चर (**Fracture**) हड्डी का टूटना और डिसलोकेशन (**Dislocation**) जोड़ की हड्डियों का अपनी सामान्य स्थिति से हटना है। दर्द, सूजन, आकार में बदलाव तथा गति में कठिनाई हो सकती है।

प्राथमिक सहायता

- घायल भाग को जिस स्थिति में है उसी में सहारा दें।
- चलाना, खींचना, सीधा करना या जोड़ बैठाना न करें।
- खुला घाव हो तो साफ ड्रेसिंग रखें; निकली हड्डी पर दबाव या उसे अंदर धकेलना नहीं।
- प्रशिक्षित हों और आवश्यकता हो तो उपयुक्त स्प्लिंट तथा नरम सहारा उपयोग करें।
- गंभीर चोट में आपात मदद और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करें।

रक्त परिसंचरण

उँगलियों का रंग, गर्माहट, संवेदना और बढ़ती सूजन देखें। सहारा या बंधन बहुत कसने से परिसंचरण प्रभावित हो सकता है।

खुला और बंद फ्रैक्चर

खुले फ्रैक्चर में घाव का हड्डी की चोट से संबंध होता है। बंद फ्रैक्चर में बाहर घाव जरूरी नहीं है। दोनों में गंभीर नुकसान और चिकित्सा की जरूरत संभव है।

निदान

चिकित्सकीय जाँच तथा आवश्यकता के अनुसार एक्स-रे से स्थिति का आकलन होता है।

> प्राथमिक सहायक हड्डी या जोड़ को ठीक स्थिति में बैठाने का प्रयास नहीं करता।

सिर, गर्दन और रीढ़ की चोट

Head, Neck and Spinal Injuries

चोट का संदेह

ऊँचाई से गिरना, सिर पर जोरदार चोट, भारी वस्तु लगना या बड़ी दुर्घटना में गर्दन और रीढ़ की चोट संभव है। व्यक्ति को उठाकर चलाना नुकसान बढ़ा सकता है।

चेतावनी संकेत

संकेत	महत्त्व
बेहोशी, भ्रम या बढ़ती नींद	गंभीर सिर की चोट का संदेह
बार-बार उल्टी या बढ़ता सिरदर्द	तत्काल समीक्षा जरूरी
दौरा, कमजोरी या बोलने में बदलाव	आपात संकेत
गर्दन-पीठ में गंभीर दर्द, सुन्नपन	रीढ़ या तंत्रिका की चोट का संदेह

प्राथमिक सहायता

112 पर सहायता बुलाएँ। अनावश्यक गति रोकें और सिर-गर्दन को आरामदायक स्थिर स्थिति में रहने दें। जबरदस्ती सीधा न करें। प्रतिक्रिया और श्वसन देखते रहें।

वायुमार्ग की प्राथमिकता

साँस सामान्य न हो तो जीवनरक्षक सहायता आवश्यक है। रीढ़ की सुरक्षा के साथ वायुमार्ग खुला रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है; आपात निर्देश लें।

बाद की निगरानी

हल्की चोट समझकर भेजे गए व्यक्ति को भी बिगड़ते लक्षण पर तुरंत चिकित्सा चाहिए। चिकित्सा के बाद मिले निगरानी और गतिविधि संबंधी निर्देश पालन करें।

> सिर की चोट में बाहरी घाव छोटा होने से भीतर की चोट हल्की होना सुनिश्चित नहीं होता।

गर्मी, आग और गरम तरल से जलना

Burns and Scalds

जलने की पहचान

आग या गरम वस्तु से जलना **Burn** और गरम तरल या भाप से झुलसना **Scald** कहलाता है। लालिमा, दर्द, फफोला या गहरी चोट संभव है। कम दर्द होना हमेशा हल्की चोट का संकेत नहीं है।

तत्काल सहायता

- सुरक्षित तरीके से गर्मी का संपर्क रोकें। कपड़ों में आग हो तो दौड़ने के बजाय रुकना, नीचे लेटना और लुढ़कना उपयोगी है।
- प्रभावित भाग को शीतल बहते पानी से लगभग 20 मिनट ठंडा करें।
- पास के आभूषण तथा ढीले कपड़े हटाएँ; चिपका कपड़ा न खींचें।
- ठंडा होने पर साफ, न चिपकने वाला आवरण ढीला रखें।
- बाकी शरीर गर्म रखें, विशेषकर बच्चे और वृद्ध में।

चिकित्सा की जरूरत

बड़ी या गहरी चोट, चेहरा, हाथ, जननांग, प्रमुख जोड़, धुएँ का संपर्क तथा छोटे बच्चे की चोट में चिकित्सा लें। साँस की समस्या में तत्काल आपात सहायता चाहिए।

क्या न करें?

बर्फ, घी, तेल, मक्खन या टूथपेस्ट न लगाएँ। फफोले न फोड़ें और जली त्वचा न छीलें।

> सामान्य तापजनित जलन में पानी से ठंडा करना जरूरी है; पूरे व्यक्ति को बहुत ठंडा न होने दें।

अम्ल और रसायन से जलना

Acid and Chemical Burns

जोखिम की पहचान

सफाई पदार्थ, तेजाब, क्षार और अन्य रसायन त्वचा या आँख को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सहायक स्वयं रसायन के संपर्क से बचे तथा चिकित्सा तुरंत बुलाए।

त्वचा पर रसायन

- सुरक्षित हों तो दस्ताने या अन्य सुरक्षा लें।
- सूखे रसायन को सावधानी से झाड़ें; फैलने और साँस में जाने से बचाएँ।
- दूषित कपड़े हटाएँ, लेकिन त्वचा से चिपके भाग को न खींचें।
- शीतल या गुनगुने बहते पानी से प्रभावित त्वचा लगातार धोएँ; सामान्य रासायनिक जलन में लगभग 1 घंटे तक सिंचाई की जरूरत हो सकती है।
- मदद बुलाना और अस्पताल तक पहुँचाना साथ जारी रखें।

पदार्थ-विशेष निर्देश

यदि रसायन की सुरक्षा सूचना में पानी से विशेष प्रतिक्रिया का उल्लेख हो तो बचाव दल या विष विशेषज्ञ का तत्काल निर्देश लें। केवल अनुमान से दूसरी रासायनिक वस्तु न डालें।

आँख की चोट

आँख में रसायन पड़ने पर तुरंत साफ पानी से कम-से-कम 20 मिनट धीरे सिंचाई करें और तत्काल विशेषज्ञ सेवा लें।

> अम्ल को क्षार या क्षार को अम्ल से निष्क्रिय करने का घरेलू प्रयास न करें।

बिजली का झटका

Electric Shock

संपर्क तोड़ने से पहले सुरक्षा

जब तक बिजली का स्रोत सुरक्षित रूप से बंद और संपर्क समाप्त न हो, व्यक्ति या तार को न छुएँ। गीला फर्श, खुले तार और ऊँचे वोल्टेज का खतरा विशेष है।

प्राथमिक सहायता

चरण	कार्रवाई
सुरक्षित दूरी	व्यक्ति, तार और आसपास के खतरे से दूरी रखें
स्रोत बंद	सुरक्षित हो तभी मुख्य बिजली बंद करें; अन्यथा विशेषज्ञ मदद
सहायता	112 पर घटना और विद्युत खतरा बताएँ
संपर्क समाप्त होने पर	प्रतिक्रिया तथा सामान्य साँस देखें
जीवनरक्षक कार्य	साँस सामान्य नहीं तो **CPR** और **AED** की व्यवस्था

सामान्य गलतियाँ

पानी डालना, नंगे हाथ से खींचना और केवल लकड़ी या रबर का अनुमानित सहारा लेकर बचाव करना सुरक्षित मान लेना उचित नहीं है। गिरे हाई-वोल्टेज तार से दूरी रखें और संबंधित विशेषज्ञ को बुलाएँ।

अंदर की चोट

बाहर छोटी जलन होने पर भी हृदय की लय, मांसपेशी और अंदर के ऊतक प्रभावित हो सकते हैं। घरेलू विद्युत झटके के बाद भी चिकित्सकीय समीक्षा आवश्यक है; बेहोशी, दर्द या जलन में विशेष प्राथमिकता है।

> बिजली का संपर्क समाप्त होने से पहले स्पर्श करना सहायक को भी गंभीर चोट पहुँचा सकता है।

विषाक्त पदार्थ और दवाओं से दुर्घटना

Poisoning and Medicine Accidents

विषाक्तता के रास्ते

विषाक्तता (**Poisoning**) निगलने, साँस से, त्वचा या आँख के संपर्क से हो सकती है। दवा की गलत मात्रा, कीटनाशक, सफाई रसायन और मिट्टी के तेल जैसे पदार्थ घरेलू जोखिम हैं।

सहायता की मुख्य दिशा

आपात चिकित्सा या विष संबंधी विशेषज्ञ सहायता लें। पदार्थ, मात्रा की संभावना, समय और व्यक्ति की स्थिति बताएँ। पैकेट या बोतल सुरक्षित हो तो पहचान के लिए रखें; उसे लेने के लिए सहायता में देरी न करें।

क्या न करें?

- उल्टी न कराएँ और नमक-पानी देकर उबकाई न लाएँ।
- दूध, तेल, नींबू या दूसरी वस्तु से “जहर काटने” का प्रयास न करें।
- बिना चिकित्सकीय निर्देश भोजन, पेय, चारकोल या दवा न दें।
- बेहोश व्यक्ति के मुँह में कुछ न डालें।

संपर्क के अनुसार कार्रवाई

रसायन लगे कपड़े सुरक्षित हटाना और त्वचा की सिंचाई उपयोगी हो सकती है। साँस द्वारा विषाक्तता में स्वयं जोखिम उठाकर दूषित क्षेत्र में प्रवेश न करें।

लक्षण देर से भी

पदार्थ निगलने के बाद तुरंत लक्षण न होना सुरक्षा का प्रमाण नहीं है। खासकर बच्चे में संभावित संपर्क पर सलाह जल्दी लें।

> विषाक्तता में पदार्थ की पहचान और समय पर चिकित्सा घरेलू अनुमान से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

गैस, धुआँ और कार्बन मोनोऑक्साइड

Gas, Smoke and Carbon Monoxide

अलग खतरे

LPG का रिसाव आग और विस्फोट का खतरा बन सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड (**Carbon Monoxide**; **CO**) अधूरे दहन से बनने वाली गंधहीन और रंगहीन विषैली गैस है। गंध न होने पर भी **CO** का जोखिम हो सकता है।

CO के संभावित संकेत

सिरदर्द, चक्कर, मतली, कमजोरी, भ्रम या बेहोशी हो सकती है। एक ही बंद स्थान में कई लोगों का अस्वस्थ होना और बाहर आने पर कुछ सुधार महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं।

तत्काल सुरक्षा

- सुरक्षित रास्ते से बाहर ताजी हवा वाले स्थान पर जाएँ।
- दूसरों को जोखिम की जानकारी दें और आपात मदद बुलाएँ।
- दूषित स्थान में बिना विशेषज्ञ बचाव उपकरण प्रवेश न करें।
- व्यक्ति बाहर सुरक्षित आने पर प्रतिक्रिया और साँस देखें; आवश्यकता पर **CPR** करें।

LPG रिसाव

माचिस, आग, विद्युत स्विच या उपकरण से चिंगारी न बनाएँ। सुरक्षित हो तभी आपूर्ति बंद करें। बाहर सुरक्षित स्थान से सहायता बुलाएँ।

बचाव

अंगीठी, जनरेटर और दहन उपकरण बंद कमरे में उपयोग न करें। उपयुक्त वेंटिलेशन, रखरखाव और **CO** अलार्म उपयोगी हैं।

> **CO** को सूँघकर पहचानना संभव नहीं; संदिग्ध संपर्क में तुरंत बाहर और चिकित्सा की व्यवस्था करें।

वयस्क के गले में वस्तु फँसना

Choking in an Adult

आंशिक और गंभीर अवरोध

यदि व्यक्ति प्रभावी खाँस और बोल सकता है तो खाँसने के लिए प्रोत्साहित करें और निगरानी रखें। बोल न पाना, प्रभावी खाँसी न होना या साँस न ले पाना गंभीर अवरोध (**Choking**) के संकेत हैं।

सचेत वयस्क में सहायता

चरण	मुख्य कार्य
मदद	किसी को 112 पर फोन करने को कहें
पीठ पर प्रहार	आगे झुकाकर कंधों की हड्डियों के बीच हाथ की एड़ी से अधिकतम 5 प्रहार
पेट पर दबाव	असर न हो तो पीछे से नाभि के ऊपर और उरोस्थि के नीचे अधिकतम 5 अंदर-ऊपर दबाव
दोहराव	राहत न हो तो 5 पीठ प्रहार और 5 पेट दबाव बदल-बदलकर

विशेष सावधानियाँ

प्रत्येक प्रयास के बाद राहत देखें; वस्तु निकल जाए तो रोकें। गर्भवती व्यक्ति या पेट के चारों ओर बाँह न पहुँचने पर प्रशिक्षित छाती-दबाव तकनीक का उपयोग होता है।

व्यक्ति अचेत हो जाए तो सुरक्षित नीचे लाकर **CPR** शुरू करें। दिखाई न देने वाली वस्तु के लिए मुँह में अंधाधुंध उँगली न डालें।

बाद की समीक्षा

पेट या छाती के दबाव के बाद चिकित्सा समीक्षा जरूरी है, क्योंकि चोट या बचा अवरोध संभव है।

> प्रभावी खाँसी वाले व्यक्ति में अनावश्यक पीठ प्रहार या पानी देना उचित नहीं है।

शिशु और बच्चे में गले की रुकावट

Choking in Infants and Children

शिशु की अलग तकनीक

एक वर्ष से कम आयु के शिशु में पेट पर दबाव (**Abdominal Thrust**) नहीं दिया जाता। अचानक रो न पाना, कमजोर खाँसी या साँस में गंभीर बाधा के संकेत पर सहायता जल्दी बुलाएँ।

सचेत शिशु में प्रशिक्षित सहायता

- सिर और गर्दन संभालकर शिशु को अग्रबाहु पर पेट के बल रखें; सिर छाती से नीचे रहे।
- कंधों की हड्डियों के बीच हाथ की एड़ी से अधिकतम 5 पीठ प्रहार दें।
- असर न हो तो पलटकर पीठ के बल सहारा दें और उरोस्थि पर अधिकतम 5 छाती के थ्रस्ट दें।
- प्रशिक्षित दो-अँगूठा घेरने की तकनीक में उरोस्थि के निचले आधे भाग पर नियंत्रित थ्रस्ट दिया जाता है।
- राहत तक दोनों क्रियाएँ बदलें; शिशु अचेत हो तो बाल **CPR** शुरू करें और आपात निर्देश लें।

बड़े बच्चे

एक वर्ष से बड़े बच्चे में आयु और आकार के अनुसार पीठ प्रहार तथा पेट दबाव की प्रशिक्षित तकनीक उपयोग होती है। सामान्य खाँसी हो तो प्रोत्साहित करें।

क्या न करें?

पैर पकड़कर उल्टा लटकाना, झकझोरना या बिना दिखाई वस्तु निकालने के लिए उँगली डालना नहीं।

> शिशु की सहायता वयस्क तकनीक का छोटा संस्करण नहीं है; व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यक है।

डूबना और पानी में दुर्घटना

Drowning and Water Accidents

सुरक्षित बचाव पहले

पानी में बचाव का प्रशिक्षण न हो तो स्वयं पानी में न उतरें। सुरक्षित किनारे से बचाव-साधन या तैरने वाला उपकरण पहुँचाएँ और मदद बुलाएँ। डूबता व्यक्ति बचाने वाले को भी डुबो सकता है।

बाहर निकालने के बाद

प्रतिक्रिया और सामान्य साँस देखें। प्रशिक्षित सहायक सामान्य साँस न होने पर प्रारंभिक 5 बचाव साँसें देकर **CPR** शुरू करता है। वयस्क में आगे 30 छाती-दबाव और 2 साँसें का क्रम उपयोग होता है; कॉल संचालक से मार्गदर्शन लें।

यदि साँस देना संभव नहीं तो छाती-दबाव की शुरुआत में देरी न करें। उपलब्ध **AED** के लिए छाती सुखाकर उपकरण के निर्देश पालन करें।

क्या न करें?

पेट दबाकर या उल्टा लटकाकर पानी निकालने में समय न गँवाएँ। इससे उल्टी और फेफड़ों में सामग्री जाने का जोखिम बढ़ सकता है तथा जीवनरक्षक सहायता देर से मिलती है।

आगे की जरूरत

ठंड से बचाएँ और चिकित्सा की व्यवस्था करें। पानी की दुर्घटना के बाद खाँसी, साँस की समस्या, अत्यधिक थकान या अस्वस्थता में तत्काल मूल्यांकन जरूरी है।

> डूबने में सुरक्षित बचाव और जल्दी श्वसन सहायता महत्वपूर्ण हैं; पानी निकालना प्राथमिक लक्ष्य नहीं है।

दौरा पड़ना

Seizures

पहचान

दौरे (**Seizure**) में झटके, शरीर अकड़ना, प्रतिक्रिया कम होना या अन्य बदलाव हो सकते हैं। हर दौरा मिर्गी का अंतिम निदान नहीं है; पहली घटना की चिकित्सकीय समीक्षा जरूरी है।

प्राथमिक सहायता

- समय नोट करें और आसपास की कठोर या नुकीली वस्तु हटाएँ।
- सिर के नीचे नरम वस्तु रखें और गर्दन के कसते कपड़े ढीले करें।
- झटके जबरदस्ती न रोकें और व्यक्ति को पकड़कर दबाएँ नहीं।
- मुँह में उँगली, चम्मच, पानी या दवा न डालें।
- दौरा रुकने के बाद साँस देखें; बिना चोट और सामान्य साँस में करवट उपयुक्त हो सकती है।

तत्काल सहायता कब?

दौरा लगभग 5 मिनट या अधिक चले, बार-बार आए और चेतना न लौटे, साँस में समस्या हो, गंभीर चोट लगी हो, पानी में हुआ हो या पहली बार हो तो आपात मदद लें। पहले से बनी देखभाल योजना हो तो उसका पालन करें।

बाद का व्यवहार

व्यक्ति भ्रमित या थका हो सकता है। शांत आश्वासन दें और पूरी तरह जाग्रत होने तक कुछ मुँह से न दें।

> दौरे में जीभ निगल लेने के डर से मुँह में वस्तु डालना नुकसान पहुँचा सकता है।

गंभीर एलर्जी और एनाफिलैक्सिस

Anaphylaxis

आपात संकेत

भोजन, दवा या कीट-दंश के बाद गले या जीभ की सूजन, आवाज बदलना, साँस की कठिनाई, चक्कर या बेहोशी गंभीर एलर्जी (**Anaphylaxis**) के संकेत हो सकते हैं। त्वचा पर चकत्ता हमेशा उपस्थित हो, यह जरूरी नहीं।

तत्काल सहायता

112 पर फोन करके गंभीर एलर्जी बताएँ। व्यक्ति के पास निर्धारित एड्रेनालिन ऑटो-इंजेक्टर (**Adrenaline Auto-Injector**) हो तो उसके निर्देश और प्रशिक्षण के अनुसार जाँघ के बाहरी भाग में उपयोग में सहायता करें।

स्थिति और दूसरी खुराक

व्यक्ति को लेटाएँ; अचानक खड़ा या चलने न दें। साँस में कठिनाई हो तो पैर फैले रखते हुए ऊपरी शरीर आरामदायक उठाया जा सकता है। गर्भवती व्यक्ति को बाईं करवट उपयुक्त है।

5 मिनट में सुधार न हो और दूसरा उपयुक्त ऑटो-इंजेक्टर उपलब्ध हो तो निर्देश के अनुसार दूसरी खुराक उपयोग करें। राहत मिले तो भी आपात चिकित्सा जरूरी है।

आवश्यक अंतर

एंटीहिस्टामिन गंभीर श्वसन या परिसंचरण संकट में एड्रेनालिन का विकल्प नहीं है। सामान्य सहायक बिना प्रशिक्षण सिरिंज से दवा की मात्रा निकालकर इंजेक्शन देने का प्रयास न करे।

> एनाफिलैक्सिस में सहायता, उपयुक्त एड्रेनालिन और सुरक्षित स्थिति में देरी नहीं करनी चाहिए।

जानवर और मनुष्य के काटने की चोट

Animal and Human Bites

घाव और संक्रमण का जोखिम

कुत्ते, बिल्ली या अन्य स्तनधारी के काटने या खरोंच से घाव, संक्रमण और रेबीज़ का जोखिम हो सकता है। मनुष्य के काटने में भी गंभीर संक्रमण संभव है।

प्राथमिक सहायता

गंभीर रक्तस्राव हो तो पहले नियंत्रण करें। संभावित रेबीज़ संपर्क का घाव तुरंत साबुन और पर्याप्त बहते पानी से लगभग 15 मिनट अच्छी तरह धोएँ। शीघ्र स्वास्थ्य केंद्र जाएँ।

चिकित्सकीय समीक्षा

आवश्यकता	उद्देश्य
घाव का आकलन	गहराई, संक्रमण और ऊतक की चोट
रेबीज़ के बाद बचाव (**PEP**)	संपर्क के अनुसार टीका तथा जरूरी होने पर इम्युनोग्लोबुलिन
टिटनेस की समीक्षा	घाव और पूर्व सुरक्षा के अनुसार
अन्य उपचार	आवश्यकता के अनुसार संक्रमण तथा चोट का प्रबंधन

देरी न करें

घाव छोटा होने, पशु परिचित होने या तुरंत लक्षण न आने से जोखिम समाप्त नहीं माना जाता। पशु का निरीक्षण संभव हो तो उसकी जानकारी चिकित्सक को दें; निरीक्षण के लिए उपचार की सलाह लेने में देरी न करें।

क्या न करें?

मिर्च, मिट्टी या घरेलू पदार्थ न लगाएँ। रेबीज़ के लक्षण आने का इंतजार न करें।

> संभावित रेबीज़ संपर्क में घाव धोना और समय पर चिकित्सा, दोनों जरूरी हैं।

साँप के काटने की प्राथमिक सहायता

Snakebite First Aid

हर संदेह को गंभीर लें

दो दाँत के निशान न दिखना या तुरंत दर्द न होना विषैले काटने को खारिज नहीं करता। व्यक्ति को शांत रखें और शीघ्र ऐसी स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचाएँ जहाँ आवश्यक उपचार मिल सके।

सुरक्षित सहायता

- व्यक्ति को आराम से लिटाएँ और चलना-फिरना कम करें।
- काटे हुए अंग को उपयुक्त सहारा देकर स्थिर रखें।
- सूजन की संभावना से अंगूठी या कसते आभूषण सुरक्षित हटाएँ।
- आपात परिवहन बुलाएँ; व्यक्ति को स्वयं चलाकर ले जाने से बचें।
- प्रतिक्रिया और श्वसन पर निगरानी रखें।

क्या न करें?

काटना, चूसना, घाव जलाना, बर्फ लगाना, मालिश, बिजली देना और बहुत कसकर रस्सी बाँधना नहीं। साँप पकड़ने या मारने के लिए समय तथा अपनी सुरक्षा न गँवाएँ।

विशेष तकनीक की सीमा

दबाव वाली इमॉबिलाइज़ेशन पट्टी हर प्रकार के साँप के काटने के लिए सामान्य नियम नहीं है। बिना उपयुक्त प्रशिक्षण और स्थानीय चिकित्सा निर्देश इसे न अपनाएँ।

अस्पताल की भूमिका

एंटीवेनम (**Antivenom**) और अन्य उपचार की जरूरत चिकित्सकीय आकलन से तय होती है। घरेलू “विष उतारना” उनका विकल्प नहीं है।

> साँप के काटने में स्थिरता और जल्दी अस्पताल तक पहुँच सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक दिशा है।

कीट-दंश और स्थानीय प्रतिक्रिया

Insect Bites and Stings

सामान्य प्रतिक्रिया

कीट के काटने या डंक से दर्द, खुजली और स्थानीय सूजन हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में गंभीर एलर्जी तथा कभी संक्रमण हो सकता है।

सहायता

मधुमक्खी का डंक दिखाई दे तो उसे किनारे से सावधानीपूर्वक खुरचकर हटाएँ। त्वचा साफ करें। दर्द या सूजन में कपड़े में लिपटा ठंडा पैक थोड़े समय रखें; बर्फ सीधे त्वचा पर न रखें।

विशेष परिस्थितियाँ

स्थिति	कार्रवाई
केवल स्थानीय दर्द और सूजन	सफाई, ठंडा सहारा और निगरानी
पस, बढ़ती गर्माहट या दर्द	चिकित्सा समीक्षा
मुँह, गला या आँख के पास डंक	शीघ्र चिकित्सकीय सहायता
साँस की बाधा, गले की सूजन या बेहोशी	एनाफिलैक्सिस की आपात सहायता

चिचड़ी से अंतर

चिचड़ी (**Tick**) हटाने की तकनीक मधुमक्खी के डंक से अलग है। उपयुक्त महीन चिमटी से त्वचा के पास पकड़कर सावधानी से ऊपर निकाला जाता है; उसे जलाना या रसायन डालना नहीं। संदेह में सहायता लें।

बचाव

जूते, सुरक्षित कपड़े और कीटों के घोंसले से दूरी उपयोगी हैं।

> स्थानीय सूजन और गंभीर पूरे शरीर की एलर्जी अलग हैं; साँस की समस्या को साधारण डंक न मानें।

आँख की चोट और विदेशी वस्तु

Eye Injuries and Foreign Objects

आँख की संवेदनशीलता

धूल, रसायन, चोट या फँसी वस्तु आँख को प्रभावित कर सकती है। देखने में कमी, गंभीर दर्द और आँख में गहरा घाव तत्काल चिकित्सा की जरूरत हैं।

परिस्थिति के अनुसार सहायता

स्थिति	सुरक्षित दिशा
ढीली धूल या छोटा कण	आँख न रगड़ें; साफ पानी से धीरे धोएँ
रसायन	तुरंत लगातार कम-से-कम 20 मिनट साफ पानी से सिंचाई
गहरी या फँसी वस्तु	न निकालें, दबाव न दें; तत्काल विशेषज्ञ सेवा
चोट के बाद दृष्टि में बदलाव	तत्काल चिकित्सकीय आकलन

सिंचाई की सावधानी

पलकों को धीरे खुला रखें। सिर इस प्रकार झुकाएँ कि दूषित पानी दूसरी आँख में न जाए। बहुत तेज धार न रखें। संपर्क लेंस आसानी से हट सके तो हटाएँ, लेकिन सिंचाई में देरी न करें।

क्या न करें?

आँख में चिमटी, कपड़े का कोना, अनिर्दिष्ट ड्रॉप या घरेलू पदार्थ न डालें। गहरी वस्तु पर पट्टी कसकर दबाना नुकसान बढ़ा सकता है।

आगे की सेवा

धोने के बाद दर्द, कण का एहसास या धुंधला देखना रहे तो समीक्षा लें। रासायनिक चोट में सिंचाई के बाद भी तत्काल सेवा जरूरी है।

> आँख में रसायन के संपर्क में पानी से तुरंत सिंचाई और चिकित्सा की व्यवस्था साथ करें।

कान, नाक और निगली हुई वस्तु

Foreign Objects, Button Batteries and Magnets

बच्चे में विदेशी वस्तु

मोती, खिलौने का भाग या बीज कान और नाक में जा सकते हैं। दर्द, एक तरफ से दुर्गंध वाला स्राव या अचानक समस्या में वस्तु की संभावना हो सकती है।

सहायता की दिशा

कान या नाक में चिमटी, पिन या उँगली गहराई में डालकर न खोजें। बच्चा शांत रहे और उचित चिकित्सा लें। बिना निर्देश पानी या तेल न डालें, खासकर बैटरी या अनिश्चित वस्तु में।

बटन बैटरी और चुंबक

बटन बैटरी (**Button Battery**) निगलना या कान-नाक में फँसना आपात स्थिति है। एक से अधिक चुंबक निगलने की संभावना भी गंभीर है। बच्चा सामान्य दिखे तो भी तुरंत आपात विभाग से संपर्क करें।

क्या न करें?

उल्टी न कराएँ और मल में निकलने का इंतजार न करें। आपात टीम के पदार्थ-विशेष निर्देश के बिना खाने-पीने की वस्तु या घरेलू उपाय न दें। सुरक्षित उपलब्ध हो तो वस्तु का पैकेट या उदाहरण साथ रखें।

वायुमार्ग से अंतर

निगली हुई वस्तु और साँस के रास्ते की वस्तु अलग स्थितियाँ हैं। साँस, बोलने या प्रभावी खाँसी में बाधा हो तो choking की सहायता और 112 आवश्यक हैं।

> बैटरी और चुंबक की दुर्घटना में लक्षण आने की प्रतीक्षा नहीं की जाती।

गर्मी से थकावट और हीटस्ट्रोक

Heat Exhaustion and Heatstroke

गर्मी से संबंधित बीमारी

गर्मी, व्यायाम, पानी की कमी तथा बंद गरम वातावरण से शरीर प्रभावित हो सकता है। गर्मी से थकावट (**Heat Exhaustion**) और हीटस्ट्रोक (**Heatstroke**) की गंभीरता अलग है।

स्थिति	संभावित संकेत	प्राथमिक दिशा
गर्मी से थकावट	पसीना, कमजोरी, सिरदर्द, चक्कर	ठंडी जगह, आराम और सुरक्षित तरल
हीटस्ट्रोक का संदेह	गर्म शरीर के साथ भ्रम, दौरा या बेहोशी	112 और तुरंत शरीर ठंडा करना

सहायता

छाया या ठंडी जगह ले जाएँ। अनावश्यक कपड़े हटाएँ और त्वचा को पानी से गीला करके हवा दें। ठंडे पैक कपड़े में लपेटकर उपयोग कर सकते हैं। पूरी तरह जाग्रत और निगल सकने वाला व्यक्ति पानी या उचित पुनर्जलीकरण पेय छोटे घूँट ले सकता है।

आपात संकेत में प्रतीक्षा नहीं

भ्रम या बेहोशी में 30 मिनट का इंतजार न करें; तुरंत आपात सहायता चाहिए। हल्की थकावट में भी लगभग 30 मिनट में सुधार न हो या स्थिति बिगड़े तो तत्काल सेवा लें।

महत्वपूर्ण सावधानी

बेहोशी में मुँह से तरल न दें। हीटस्ट्रोक में पसीना आना संभव है; सूखी त्वचा जरूरी शर्त नहीं।

> हीटस्ट्रोक चिकित्सा आपात स्थिति है; सहायता बुलाते हुए जल्दी ठंडा करना शुरू करें।

ठंड से शरीर का ताप गिरना

Hypothermia

हाइपोथर्मिया

हाइपोथर्मिया (**Hypothermia**) में शरीर का आंतरिक ताप सामान्य से बहुत कम हो जाता है, सामान्यतः 35°C से नीचे। ठंड, गीले कपड़े और लंबे संपर्क में जोखिम बढ़ता है।

संभावित संकेत

कँपकँपी, ठंडी त्वचा, अस्पष्ट बोलना, धीमी प्रतिक्रिया, भ्रम और बहुत अधिक नींद हो सकती है। गंभीर स्थिति में कँपकँपी कम या समाप्त भी हो सकती है।

प्राथमिक सहायता

- सुरक्षित अंदर या हवा से बची जगह पहुँचाएँ।
- गीले कपड़े सावधानी से हटाकर सूखे कपड़े और कंबल दें।
- सिर सहित शरीर को ढकें तथा व्यक्ति को कोमलता से संभालें।
- आपात मदद बुलाएँ और श्वसन देखते रहें।
- पूरी तरह जाग्रत तथा सुरक्षित निगलने वाले व्यक्ति को गर्म गैर-मादक पेय दिया जा सकता है।

क्या न करें?

गर्म पानी का स्नान, सीधे बहुत गर्म बोतल, आग या जोरदार मालिश से अचानक गरम न करें। शराब न दें। अचेत व्यक्ति को कुछ मुँह से न दें।

श्वसन में बदलाव

प्रतिक्रिया नहीं और साँस सामान्य नहीं तो **CPR** तथा आपात निर्देश लें।

> ठंड से बेहोशी को सामान्य नींद न समझें; धीरे सुरक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करें।

कम रक्त शर्करा की आपात स्थिति

Hypoglycaemia

हाइपोग्लाइसीमिया की पहचान

कम रक्त शर्करा (**Hypoglycaemia**) में पसीना, काँपना, भूख, चक्कर, व्यवहार बदलना या भ्रम हो सकता है। मधुमेह की कुछ दवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति में यह महत्वपूर्ण संभावना है।

जाग्रत वयस्क में सहायता

व्यक्ति पूरी तरह जाग्रत और सुरक्षित निगल सकता हो तो लगभग 15 से 20 g शीघ्र काम करने वाला कार्बोहाइड्रेट दें, जैसे लेबल के अनुसार ग्लूकोज़। उपलब्ध हो तो रक्त शर्करा जाँचें; 70 mg/dL से कम स्तर कम शर्करा का संकेत है।

दोबारा समीक्षा

लगभग 15 मिनट बाद शर्करा तथा स्थिति की पुनः समीक्षा करें। स्तर कम रहे या सुधार न हो तो उपयुक्त शीघ्र कार्बोहाइड्रेट दोहराएँ और चिकित्सा सहायता लें। ठीक होने के बाद निर्धारित योजना के अनुसार भोजन या टिकाऊ नाश्ता उपयोगी है।

बेहोशी में अलग सहायता

मुँह से चीनी, पेय या ग्लूकोज़ जेल न दें। 112 पर मदद बुलाएँ। साँस सामान्य हो तो बिना चोट में रिकवरी पोज़िशन; साँस सामान्य नहीं तो **CPR**। निर्धारित ग्लूकागॉन केवल प्रशिक्षित सहायता और उसकी योजना के अनुसार।

मात्रा की सीमा

यह वयस्क की सामान्य दिशा है; बच्चे की व्यक्तिगत मधुमेह योजना अलग हो सकती है।

> सुरक्षित निगलने की क्षमता जाँचे बिना मुँह से चीनी देना खतरनाक हो सकता है।

सीने में दर्द और स्ट्रोक की पहचान

Chest Pain and Stroke

दुर्घटना से अलग आपात स्थितियाँ

घर में अचानक बीमारी भी प्राथमिक सहायता की जरूरत बन सकती है। सीने के संदिग्ध दर्द और स्ट्रोक को केवल थकान या सामान्य कमजोरी मानकर टालना उचित नहीं है।

संदिग्ध हृदयाघात

सीने में दबाव, दर्द, साँस की कमी, पसीना या दर्द का बाँह-जवड़े तक जाना आपात संकेत हो सकते हैं। व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में रखें, 112 बुलाएँ और साथ रहें। स्वयं वाहन चलाने न दें। दवा केवल निर्धारित योजना या आपात चिकित्सकीय निर्देश के अनुसार दें।

स्ट्रोक के लिए FAST

संकेत	पहचान
F: **Face**	चेहरे का एक ओर झुकना
A: **Arm**	एक बाँह उठाने में कमजोरी
S: **Speech**	बोलने में अस्पष्टता या कठिनाई
T: **Time**	तुरंत आपात सहायता; शुरू होने का समय नोट करना

लक्षण रुक जाएँ तब भी

कुछ समय बाद सुधार हो जाने पर भी तुरंत चिकित्सा जरूरी हो सकती है। बेहोशी या निगलने की समस्या में कुछ मुँह से न दें। प्रतिक्रिया नहीं और साँस सामान्य नहीं तो **CPR** करें।

> अचानक चेहरे, बाँह या भाषा में बदलाव समय-संवेदी आपात संकेत हैं।

बच्चों में घरेलू दुर्घटनाओं की रोकथाम

Preventing Accidents in Children

आयु के अनुसार जोखिम

छोटे बच्चे वस्तु मुँह में डाल सकते हैं, ऊँचाई पर चढ़ सकते हैं और खतरा पूरी तरह नहीं समझते। केवल “सावधान रहना” कहना पर्याप्त सुरक्षा नहीं है।

जोखिम	बचाव की दिशा
छोटे खिलौने और भोजन	आयु के अनुरूप वस्तु; निगरानी में बैठकर खाना
दवा और रसायन	मूल लेबल वाले बंद पात्र, सुरक्षित ऊँचा स्थान
पानी	बाल्टी, टब और जलस्रोत के पास सतत निगरानी
गिरना	सीढ़ी-द्वार की सुरक्षा और खिड़की में उपयुक्त अवरोध
गरम तरल	कप, पतीले और तार खींचने की पहुँच से दूर
बैटरी और चुंबक	बंद बैटरी खंड तथा छोटे भाग की सुरक्षित व्यवस्था

निगरानी का अर्थ

बच्चे को पानी में छोड़कर फोन देखने या “बड़ा बच्चा देख लेगा” मानने से जोखिम बना रहता है। कम पानी भी छोटे बच्चे के लिए गंभीर हो सकता है।

सुरक्षित उदाहरण

रसायन को पेय की बोतल में भरना भ्रम पैदा करता है। मूल पात्र और सही पहचान बचाव में महत्वपूर्ण हैं।

> बच्चों की सुरक्षा में निगरानी के साथ घर की व्यवस्था बदलना आवश्यक है।

वृद्ध व्यक्तियों और गिरने का बचाव

Falls and Safety for Older Persons

गिरने के कारण

फिसलन, कम प्रकाश, अस्थिर फर्नीचर, दृष्टि की समस्या, कमजोरी और कुछ दवाओं के प्रभाव से गिरने का जोखिम बढ़ सकता है। कारण व्यक्ति तथा वातावरण, दोनों से जुड़े हो सकते हैं।

घर में सुरक्षा

- रास्ते से ढीले तार, खिलौने और फिसलने वाली चटाई हटाएँ।
- सीढ़ी, स्नानघर और रात के रास्ते में पर्याप्त प्रकाश रखें।
- आवश्यक हैंडरेल और पकड़ने की सुरक्षित व्यवस्था बनाएँ।
- उपयुक्त जूते तथा जरूरत के अनुसार सहायक साधन उपयोग करें।
- चक्कर, बार-बार गिरना या दवा संबंधी समस्या पर चिकित्सकीय समीक्षा लें।

गिरने के बाद

तुरंत खींचकर खड़ा न करें। दर्द, सिर की चोट, साँस, चेतना और पैर-श्रोणि की चोट देखें। गंभीरता हो तो आपात सहायता और सुरक्षित स्थिति बनाएँ।

स्वतंत्रता का सम्मान

सुरक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की हर गतिविधि रोकना नहीं है। क्षमता के अनुसार सुरक्षित गतिविधि, सहयोग और उपयुक्त वातावरण अधिक उपयोगी हैं।

विशेष ध्यान

रक्त पतला करने वाली दवा लेने वाले व्यक्ति में सिर की चोट को हल्का न मानें।

> गिरने का बचाव व्यक्ति की जरूरत, घर की सुगमता और स्वास्थ्य समीक्षा को जोड़ता है।

रसोई, आग और विद्युत सुरक्षा

Kitchen, Fire and Electrical Safety

रसोई का सुरक्षित प्रबंधन

गरम पात्र का हत्था सुरक्षित दिशा में रखें। गरम तेल, भाप और तरल संभालते समय बच्चे की पहुँच दूर हो। चाकू और धारदार उपकरण सुरक्षित स्थान पर रखें।

क्षेत्र	प्रमुख बचाव
गैस	उपयुक्त रखरखाव, वेंटिलेशन और रिसाव की समीक्षा
बिजली	सही तार, अधिक भार से बचाव और गीले हाथ से दूरी
आग	निकास स्पष्ट, उपयुक्त अलार्म और बचाव योजना
रसायन	सफाई पदार्थ अलग पहचान तथा सुरक्षित भंडारण

आग लगने पर

बड़ी आग या धुएँ में बचाव का प्रयास करके न फँसें। लोगों को बाहर निकालें, बाहर से आपात सहायता बुलाएँ और वापस प्रवेश न करें।

तेल की आग

गरम तेल की आग पर पानी न डालें और जलते पात्र को उठाकर बाहर न ले जाएँ। आग नियंत्रित करने का प्रशिक्षण न हो या सुरक्षित स्थिति न हो तो बाहर निकलें और अग्निशमन सहायता लें।

धुएँ का जोखिम

धुआँ और गर्म हवा श्वसन को प्रभावित कर सकते हैं। बाहर आने के बाद साँस, आवाज या चेतना में बदलाव पर चिकित्सा जरूरी है।

> घरेलू सुरक्षा में रखरखाव, सही उपयोग और बाहर निकलने की स्पष्ट योजना साथ चाहिए।

घरेलू प्राथमिक चिकित्सा पेटी

The Home First Aid Kit

पेटी का उद्देश्य

प्राथमिक चिकित्सा पेटी (**First Aid Kit**) प्रारंभिक सहायता के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध रखती है। सामग्री साफ, ठीक अवस्था में और उपयोगकर्ता को ज्ञात होनी चाहिए।

सामग्री	उपयोग की दिशा
कीटाणुरहित ड्रेसिंग (**Sterile Dressing**) और गॉज़	छोटे घाव ढकना तथा दबाव में सहायता
रोलर और त्रिकोणीय पट्टी	उपयुक्त सहारा और ड्रेसिंग स्थिर रखना
दस्ताने	रक्त और शरीर के द्रव से सुरक्षा
टेप तथा छोटी सुरक्षित कैंची	सामग्री व्यवस्थित करना
साफ पानी या सलाइन की व्यवस्था	उपयुक्त सफाई और सिंचाई
ठंडा पैक और कंबल	चोट के अनुसार ठंडा सहारा तथा ठंड से बचाव
संपर्क और स्वास्थ्य जानकारी	आपात फोन, पता और जरूरी व्यक्तिगत जानकारी

रखरखाव

समाप्ति तिथि, पैकेट की सील और उपयोग के बाद सामग्री की पूर्ति देखें। बच्चों की पहुँच से सुरक्षित लेकिन जरूरत पर आसानी से उपलब्ध स्थान रखें।

दवाओं की सीमा

व्यक्तिगत निर्धारित आपात दवा अलग पहचान तथा निर्देश के साथ रखें। बिना जानकारी दूसरे व्यक्ति की दवा देना या पेटी में हर प्रकार की दवा रखना उचित व्यवस्था नहीं है।

> पेटी के साथ प्रशिक्षण और सही उपयोग का ज्ञान आवश्यक है।

सुरक्षित परिवहन और जानकारी देना

Safe Transport and Handover

कब व्यक्ति को हिलाना चाहिए?

आग, पानी या अन्य तत्काल खतरे से बचाना आवश्यक हो सकता है। खतरा न हो और बड़ी चोट का संदेह हो तो अनावश्यक उठाना, बैठाना या वाहन में ठूँसना नहीं। विशेषज्ञ परिवहन की सहायता लें।

हस्तांतरण में महत्वपूर्ण जानकारी

जानकारी	उदाहरण
घटना	गिरना, जलना या पदार्थ का संपर्क
समय	घटना तथा लक्षण शुरू होने का समय
स्थिति	प्रतिक्रिया, सामान्य साँस और गंभीर रक्तस्राव
दी गई सहायता	दबाव, सिंचाई, **CPR** या निर्धारित आपात दवा
स्वास्थ्य जानकारी	ज्ञात रोग, एलर्जी और नियमित दवा

निरीक्षण जारी रखें

सहायता आने तक व्यक्ति को अकेला न छोड़ें। प्रतिक्रिया और श्वसन में बदलाव हो तो बताएं और उपयुक्त जीवनरक्षक सहायता दें। घाव को बार-बार खोलकर न देखें।

परिवहन में सीमा

संदिग्ध हृदयाघात या बेहोशी में व्यक्ति स्वयं वाहन न चलाए। बड़ी गर्दन-रीढ़ की चोट में प्रशिक्षित परिवहन महत्वपूर्ण है।

मानसिक सहयोग

शांत भाषा और स्पष्ट जानकारी परिवार को सहयोग देती है। गलत आश्वासन या डर फैलाना उपयोगी नहीं है।

> अस्पताल तक पहुँचाना ही नहीं, सुरक्षित पहुँच और उपयुक्त जानकारी देना भी प्राथमिक सहायता का भाग है।

सामान्य गलत धारणाएँ और सही दिशा

Common Myths and Correct Actions

गलत धारणा या उपाय	सही दिशा
जलने पर घी या टूथपेस्ट	बहते पानी से ठंडा करना और उचित आवरण
विष निगलने पर उल्टी	उल्टी न कराना; पदार्थ के अनुसार चिकित्सा
नकसीर में सिर पीछे	आगे झुककर नरम भाग पर लगातार दबाव
दौरे में चम्मच मुँह में	मुँह खाली रखना और चोट से सुरक्षा
साँप के काटने पर रस्सी कसना	स्थिरता और शीघ्र अस्पताल
डूबने पर पानी निकालना	सामान्य साँस जाँच और जीवनरक्षक सहायता
फ्रैक्चर को सीधा करना	उसी स्थिति में सहारा और चिकित्सा
बिजली वाले व्यक्ति को पकड़ना	सुरक्षित रूप से संपर्क समाप्त होने तक दूरी
बेहोशी में पानी या चीनी	कुछ मुँह से नहीं; श्वसन के अनुसार सहायता

जानकारी की समीक्षा

पुरानी सुनी हुई बात या सफल होने की व्यक्तिगत कहानी किसी उपाय की सुरक्षा का पूरा प्रमाण नहीं है। स्थिति के अनुसार वैज्ञानिक दिशा और प्रशिक्षित सहायता उपयोग करें।

मुख्य उद्देश्य

गलत उपाय रोकना सहायता का हिस्सा है, लेकिन सही काम करने में देर न हो। मदद बुलाना, जीवन के खतरे पहचानना और उपयुक्त प्रारंभिक सहायता साथ करें।

> सहायता का पहला मानदंड व्यक्ति की सुरक्षा और जीवन की रक्षा है।

दुर्घटना प्रबंधन का सार

Key Actions and Chapter Review

प्राथमिक कार्य की दिशा

1	**सुरक्षा**	घटनास्थल का खतरा और स्वयं की सुरक्षा।
2	**जीवन के खतरे**	प्रतिक्रिया, सामान्य श्वसन और गंभीर रक्तस्राव।
3	**मदद और सहायता**	112 तथा स्थिति के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा।
4	**निगरानी**	सुरक्षित परिवहन और चिकित्सा तक लगातार सहयोग।

तुरंत सहायता की जरूरत वाले संकेत

प्रतिक्रिया न मिलना, सामान्य साँस न होना, गंभीर श्वसन बाधा, अनियंत्रित रक्तस्राव, शॉक, बड़ी चोट, गंभीर जलन, विषाक्तता, बटन बैटरी निगलना और साँप का काटना महत्वपूर्ण आपात स्थितियाँ हैं।

कुछ आवश्यक संख्याएँ

विषय	मुख्य संख्या या समय
भारत में आपात सहायता	112
वयस्क **CPR**	100 से 120 दबाव प्रति मिनट; 5 से 6 cm; प्रशिक्षित सहायता में 30:2
सामान्य तापजनित जलन	लगभग 20 मिनट शीतल बहता पानी
संभावित रेबीज़ संपर्क का घाव	लगभग 15 मिनट साबुन और पानी से धुलाई
नकसीर का दबाव	लगातार 10 से 15 मिनट

दुर्घटना के बाद सुधार

घटना का कारण पहचानें और घर में आवश्यक बदलाव करें। दवाओं, पानी, बिजली, गरम वस्तुओं और गिरने के जोखिम की नियमित समीक्षा उपयोगी है।

> सुरक्षित स्थान, जल्दी मदद, उपयुक्त प्राथमिक सहायता और समय पर चिकित्सा दुर्घटना प्रबंधन की केंद्रीय दिशा हैं।